LE PROBLÈME

Les patients attendent à l’urgence faute de voir où il reste un lit

16 h 48

Séjour moyen sur civière à l’urgence au Québec en 2025-2026, au-dessus de la cible ministérielle.

Santé Montérégie ; MSSS, indicateur 000360

8 %

Cible de lits occupés par des patients qui n’ont plus besoin de soins aigus (NSA). Chaque lit au-delà manque à l’urgence.

AMUQ

Pas en temps réel

L’évaluation 2026 des transferts interhospitaliers relève que la disponibilité des lits n’est pas connue en temps réel et recommande d’interconnecter les systèmes.

UETMIS CHUM et CHU de Québec, 2026

Aujourd’hui, trouver un lit dans un autre hôpital passe encore souvent par une chaîne d’appels téléphoniques.

CE QU’ARRIMO CHANGE

Une vue partagée des lits, une décision en quelques clics

Aujourd’hui

- Capacité découverte par téléphone et sur des tableaux blancs
- Transferts organisés par une chaîne d’appels
- Lits libérés mais pas encore nettoyés, sans priorité
- Patients NSA et lits fermés peu visibles

Avec Arrimo

- Lits dotés en personnel, par unité et par hôpital, en temps réel
- L’hôpital le plus proche avec un lit adapté est proposé ; le lit est bloqué
- Nettoyage dans l’ordre des patients qui attendent
- Indicateurs mesurés avant et après

Arrimo est une couche de coordination : il se branche sur les systèmes existants, il ne les remplace pas.

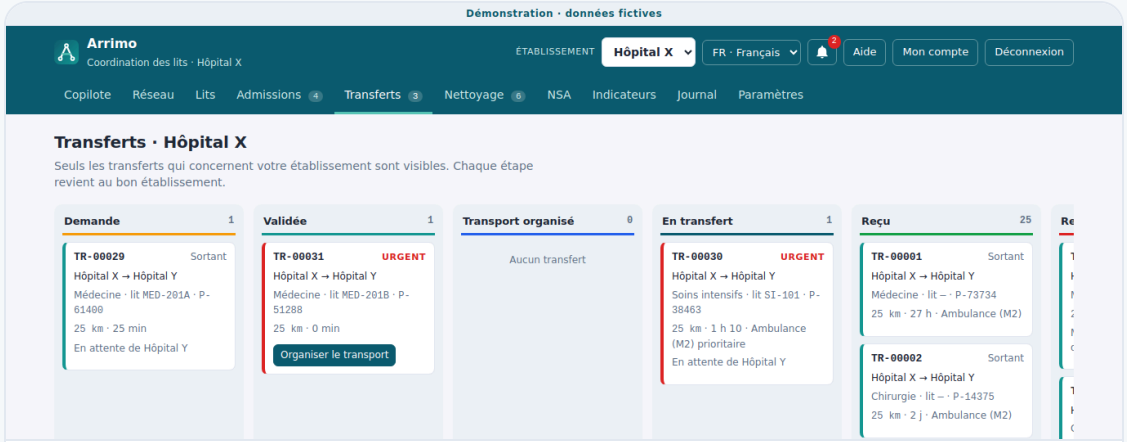
DÉMONSTRATION DONNÉES FICTIVES



1. Copilote · niveau rouge, recommandations classées



2. Chercher ailleurs · l'hôpital le plus proche avec un lit adapté



3. Transfert · accepté par le receveur, étape par étape



4. Nettoyage · sur tablette, dans l'ordre des patients qui attendent

LE COPILOTE

Le Copilote propose, un humain décide

Briefing

Pour la réunion de gestion des lits : niveau d’alerte, patients en attente, lits à nettoyer, NSA, en une phrase.

Recommandations

Classées Urgent, Important, À faire. Chacune explique pourquoi et propose une action.

Questions

« Que faire en priorité ? », « Où trouver un lit de soins intensifs ? » : réponses tirées des données du réseau.

- Aucune action automatique : chaque clic passe par les mêmes règles que l’interface, et chaque action est journalisée.
- Fonctionne sans intelligence artificielle externe ; un mode IA facultatif ne reçoit jamais de référence patient.

PROXIMITÉ D’ABORD

Le plus proche qui a un lit adapté, sauf s’il déborde

Hôpital A	18 km · 1 lit adapté · pression 112 %	Rouge · recule
Hôpital B	31 km · 3 lits adaptés · pression 78 %	Recommandé
Hôpital C	54 km · 6 lits adaptés · pression 70 %	Vert

Exemple illustratif.

- Respecte les besoins du patient : isolement, pression négative, ventilation, télémétrie.
- Un hôpital débordé recule dans le classement, pour ne pas l’étouffer.
- La raison est affichée : temps de route, lits libres, niveau.
- Un lit ne peut être pris qu’une fois : la deuxième réservation est refusée.

SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ

Aucune donnée clinique, tout est tracé

Données

Une référence patient seulement (P-00000) : ni nom, ni diagnostic. Chaque établissement choisit ce qu’il partage.

Traçabilité

Chaque changement et chaque refus sont inscrits dans un journal qui ne peut être ni modifié ni supprimé.

Comptes

Double authentification obligatoire pour l’administration, sessions fermées à la désactivation, sauvegardes quotidiennes vérifiées.

Avant toute donnée réelle

Hébergement au Canada, évaluation des facteurs relatifs à la vie privée (Loi 25) et test d’intrusion indépendant.

INDICATEURS MESURÉS

Mesurés un mois avant, puis chaque mois

INDICATEUR	MESURE	POURQUOI IL COMPTE
Délai de réponse à un transfert	De la demande à l’acceptation	Moins d’appels, décision plus rapide
Délai total de transfert	De la demande à l’arrivée	Patient pris en charge plus tôt
Attente avant lit assigné	De la demande d’admission au lit	Moins d’heures sur civière
Durée de nettoyage	Du départ au lit prêt	Lits remis en service plus vite
Taux NSA et jours d’attente	Lits occupés en attente d’une autre ressource	Rendre visibles les lits bloqués
Refus de transfert et motifs	Pas de lit, pas de personnel, plateau technique	Comprendre où le réseau bloque

Les cibles sont fixées avec les établissements. Les indicateurs s’exportent en CSV.

DÉROULEMENT DU PILOTE

Six mois, deux à trois hôpitaux voisins

Mois 0

Préparation

Entente, évaluation Loi 25, hébergement au Canada, unités et comptes.

Mois 1

Mesure de départ

Relevé des indicateurs avant Arrimo.

Mois 2

Démarrage

Formation, saisie par les équipes, accompagnement sur place.

Mois 3 à 5

Croisière

Connexion aux admissions et congés si l’informatique est prête ; ajustements.

Mois 6

Bilan

Résultats comparés au départ : poursuivre, étendre ou arrêter.

Unités visées : urgence, médecine, chirurgie, soins intensifs (à confirmer avec les équipes). Utilisateurs : coordination des lits, urgence, entretien.

CE QUE NOUS DEMANDONS

Trois engagements pour démarrer

1

Un établissement porteur et 1 à 2 établissements voisins prêts à partager leur capacité.

2

Un répondant clinique (coordination des lits) et un répondant informatique.

3

En fin de pilote, un accès aux indicateurs de départ pour comparer les résultats.

CONTACT

Commençons par une démonstration de 10 minutes

Moustafa Adamou

514 569-3547

Sources : Santé Montérégie-Est, durée de séjour sur civière 2025-2026 · MSSS, indicateur 000360 et cibles 2026 · AMUQ, patients NSA et cible de 8 % · UETMIS CHUM et CHU de Québec, coordination des transferts interhospitaliers (2026)